



MANEJO DA
DOR CRÔNICA
NA APS

Guia Calgary–Cambridge para o processo de comunicação e entrevista clínica adaptada usando o Método SCEBS



Baixe e imprima este
material em formato A4.



A importância da comunicação clínica no manejo da dor crônica na APS: adaptando o guia Calgary-Cambridge e o método SCEBS

A comunicação clínica é uma ferramenta muito importante na Atenção Primária à Saúde (APS), em que o cuidado é longitudinal, abrangente e coordenado com outros pontos do sistema e apoiado na premissa do cuidado ampliado (Cunha, 2010). As habilidades de comunicação, compreendidas como tecnologias leves (Mehry, 1997), potencializam as consultas ao favorecer e fortalecer o vínculo entre o profissional e a pessoa atendida. O vínculo é fundamental para um cuidado efetivo, tendo em vista que qualifica a escuta à medida que oferece acolhimento e um olhar ampliado sobre os processos de adoecimento, contemplando aspectos biopsicossociais. Esse conjunto torna esse espaço mais resolutivo e está associado a melhor adesão ao tratamento.

Aqui, destaca-se a indicação de Portocarrero-Gross (2022) de que as interações se dão em contexto, sendo fundamental estar atento às especificidades e aos atravessamentos envolvidos no contexto da consulta. Nas palavras do autor:

“as interações se dão em um ambiente específico, entre pessoas que têm gênero, etnia e outras características, com seus determinantes sociais, suas opressões e seus privilégios. Estar aberto para caminhos e desfechos inesperados, assim como ter um entendimento macropolítico do cenário em que nossas consultas se dão, é fundamental para uma troca real e significativa para todos os envolvidos” (Portocarrero-Gross, 2022, s/p.).

Estabelecido, portanto, que a comunicação é um processo e que deve ser construído em contexto, faz-se essencial adaptar ferramentas para que o objetivo seja alcançado. **É nessa direção que se considera que o Guia de Habilidades Processuais de Comunicação Calgary-Cambridge e o Método SCEBS [Sigla para: S = *Somatic* (Somático), C = *Cognition* (Cognição), E = *Emotion* (Emoção), B = *Behavior* (Comportamento), S = *Social* (Social)] oferecem estruturas valiosas para conduzir uma entrevista clínica centrada na pessoa, e que podem ser flexíveis e adaptados para abordar as complexidades da dor crônica.**



O Guia de Habilidades Processuais de Comunicação Calgary-Cambridge na prática clínica da Dor Crônica

O Guia Calgary-Cambridge (Kurtz; Silverman; Draper, 2005) é uma estrutura consagrada internacionalmente, tornando-se um dos modelos mais utilizados e respeitados para o ensino e avaliação da comunicação clínica em todo o mundo. Objetiva promover uma melhor comunicação entre profissionais de saúde e usuários, sendo especialmente utilizado na Atenção Primária à Saúde (APS). A versão mais atualizada mantém o foco em habilidades práticas que facilitam a construção de uma relação terapêutica eficaz, centrada na pessoa.

Na prática, o Guia propõe uma abordagem estruturada para a entrevista clínica e divide o espaço da consulta em duas tarefas longitudinais e cinco etapas claras e interconectadas, como se verá abaixo:

A) TAREFAS LONGITUDINAIS

Fornecendo estrutura:

1

organizar o ambiente para otimizar o tempo e a coleta de informações.

Construindo relacionamento:

2

empatia, escuta ativa e comunicação eficaz são cruciais. Técnicas de *rapport* são importantes para uma abordagem centrada na pessoa.

B) ETAPAS

1

Início da consulta: estabelecer um vínculo de confiança, com cumprimento cordial e atenção à pessoa atendida.

2

Coleta de informações: ouvir ativamente, identificar preocupações e explorar o contexto de vida da pessoa atendida.

3

Exame físico: realizar o exame de forma respeitosa e explicando cada passo.

4

Explicação e planejamento: compartilhar informações de forma clara, usando linguagem acessível e verificando a compreensão.

5

Encerramento: resumir os pontos principais e garantir que a pessoa atendida saiba os próximos passos.



No contexto da dor crônica, essa estrutura é especialmente útil, pois a comunicação eficaz é fundamental para entender a experiência subjetiva da pessoa, suas expectativas e barreiras ao tratamento.

Pode ser adaptada para incluir uma avaliação mais detalhada dos aspectos biopsicossociais, que são cruciais para entender a experiência única de cada pessoa com dor. Por exemplo, na fase de **coleta de informações**, é importante explorar não apenas os sintomas físicos, mas também os impactos emocionais e sociais da dor. Perguntas abertas como "Como a dor afeta seu dia a dia?" ou "O que você acha que piora ou melhora sua dor?" ajudam a entender o contexto da pessoa atendida. Ao ouvir ativamente, o profissional de saúde pode identificar fatores emocionais ou sociais que agravam a dor, como estresse ou isolamento. Já na etapa de **explicação e planejamento**, o uso de analogias (como comparar a dor crônica a um "alarme que não desliga") ajuda a pessoa atendida a entender seu quadro e aderir ao plano terapêutico.

Considera-se que o Guia Calgary-Cambridge não é apenas uma técnica, mas um convite à humanização do cuidado. Lembra-nos que, além de tratar doenças, estamos cuidando de pessoas com histórias, medos e expectativas. Esse processo estruturado ajuda a garantir que as preocupações da pessoa atendida sejam abordadas, promovendo uma parceria efetiva no cuidado à saúde.



#ficaadica

Lembre-se: a comunicação efetiva é uma habilidade que se aprimora com a prática. O Guia Calgary-Cambridge é uma ferramenta valiosa, mas sua eficácia depende de como você o adapta e aplica em sua prática diária.



O Método SCEBS na prática clínica da Dor Crônica

O Método SCEBS, por sua vez, oferece uma abordagem mais integrativa, focada nos cinco pilares que compõem a experiência humana: Somático, Cognitivo, Emocional, Comportamental e Social. Essa metodologia é particularmente útil na dor crônica, pois reconhece que a dor não é apenas um fenômeno biológico, igualmente é influenciado por fatores psicológicos e sociais (Santos *et al.*, 2017).

1 S - Somático:

O foco se apoia nos aspectos físicos da dor.

Perguntas como: "Onde você sente a dor?" ou "Qual a intensidade da dor, em uma escala de 0 a 10?" ajudam a avaliar características clínicas.

2 C - Cognição:

Explora crenças e interpretações do usuário sobre a dor. Exemplo: "O que você acha que causa sua dor?" ou "O que a dor significa para você?".

3 E - Emoção:

Identifica sentimentos associados à experiência dolorosa. Perguntas como "Como a dor afeta seu humor?" ou "Você se sente frustrado ou ansioso por causa da dor?" revelam impactos psicológicos.

4 B - Comportamento (*Behavior*):

Avalia adaptações e limitações funcionais. "O que você deixou de fazer por causa da dor?" ou "Como você reage quando a dor piora?".

5 S - Social:

Analisa o impacto nas relações. "A dor afeta sua vida familiar ou social?" ou "Você conta com apoio de alguém para lidar com a dor?".



Integrando o Modelo SCEBS ao Guia Calgary-Cambridge: Um Roteiro de Entrevista Clínica para o Manejo da Dor Crônica na Atenção Primária à Saúde

As duas ferramentas vistas acima são importantes recursos para a avaliação e manejo das dores crônicas, complementando e enriquecendo o momento da consulta. A integração dessas duas abordagens permite uma avaliação mais abrangente e centrada na pessoa. Seguindo as etapas do Guia Calgary-Cambridge e as contribuições do modelo SCEBS em cada etapa, seria possível observar, por exemplo:

1.

Início da consulta:

O Guia sugere criar um ambiente acolhedor. Nesse contexto, o modelo SCEBS orienta o profissional a estabelecer *rapport* e criar um ambiente acolhedor. O SCEBS contribui com a investigação de algumas dimensões da dor, por exemplo:

Cognição (C)

Identificar expectativas:

"O que você espera desta consulta?" ou "Há algo específico que gostaria de discutir sobre sua dor?". Essas perguntas ajudam a criar um vínculo inicial e a direcionar a consulta para as necessidades da pessoa.



Emoção (E)

Avaliar estado emocional inicial: "Como você está se sentindo hoje?".



Social (S)

Explorar o contexto da pessoa: "Como está seu dia hoje?" ou "O que trouxe você até aqui?". Estas perguntas ajudam a entender o momento de vida da pessoa atendida.





2.

Coleta de Informações:

esta é a etapa mais rica para a integração das duas ferramentas, já que o guia sugere uma coleta estruturada de informações, e o SCEBS pode ajudar a aprofundar essa etapa, especialmente na dor crônica, uma vez que os fatores psicossociais são tão importantes quanto os biológicos.

Somático (S): perguntas direcionadas aos aspectos clínicos e fisiológicos da dor

- "Onde você sente a dor?"
- "Qual a intensidade da dor, em uma escala de 0 a 10?"
- "Há outros sintomas associados, como formigamento ou fraqueza?"
- "Como você descreveria sua dor?"

Cognição (C): perguntas direcionadas às crenças e expectativas, bem como gatilhos ambientais ou comportamentais

- "O que você acredita que causa sua dor?"
- "O que a dor significa para você?"
- "Como você lida com a dor no dia a dia?"
- "Onde e quando a dor começou?"

Emoção (E): perguntas que exploram o impacto emocional da dor, que muitas vezes é subestimado

- "Como a dor afeta seu humor ou suas emoções?"
- "Você se sente frustrado, ansioso ou triste por causa da dor?"

Comportamento (B): perguntas que tenham relação com a rotina, trabalho, postura

- "Há alguma situação ou atividade que piora ou melhora a dor?"
- "Como é sua rotina diária?"
- "O que você deixou de fazer por causa da dor?"
- "Como são suas atividades em casa e no trabalho?"

Social (S): perguntas que ajudam a entender o impacto social da dor e a identificar redes de apoio

- "A dor afeta sua vida social ou familiar?"
- "Você tem apoio de familiares ou amigos para lidar com a dor?"
- "A dor interfere no seu trabalho ou estudos?"



3.

Exame Físico:

durante o exame físico, o SCEBS pode orientar o profissional a:

Somático (S)

Comunicar-se de forma empática. Explicar cada passo do exame e perguntar: "Está sentindo dor aqui?" ou "Isso causa algum desconforto?"

Emoção (E)

Observar sinais não verbais: a postura, expressões faciais e gestos do paciente podem revelar aspectos emocionais e contextuais da dor.

4.

Explicação e Planejamento:

Nesta etapa, o Guia Calgary-Cambridge sugere compartilhar informações e construir um plano de cuidado junto à pessoa atendida. O SCEBS pode contribuir para:

Cognição (C)

Personalizar a explicação: usar exemplos e analogias que façam sentido para o contexto da pessoa. Por exemplo: "Sua dor parece ser como um alarme que não desliga, e vamos trabalhar juntos para ajustar esse alarme."

Comportamento (B)

Incluir estratégias práticas como: "Vamos iniciar exercícios adaptados."

Social (S)

Atentar para aspectos psicossociais no plano e sugerir redes de apoio além de medicamentos ou fisioterapia, como acompanhamento psicológico, grupos de apoio e práticas integrativas.

5.

Encerramento:

o SCEBS pode ajudar a:

Validar experiências da pessoa com dor.

Resumir os pontos principais: reforçar não apenas os aspectos biológicos, mas também os emocionais e sociais discutidos durante a consulta.

Estabelecer metas realistas: "Vamos focar em melhorar sua capacidade de realizar atividades diárias e, ao mesmo tempo, trabalhar no controle da dor."

Oferecer suporte contínuo: "Estou aqui para ajudá-lo nessa jornada. Podemos ajustar o plano conforme necessário."



Conclusão

A comunicação clínica eficaz no manejo da dor crônica requer uma abordagem centrada na pessoa, que vá além dos sintomas físicos e considere os aspectos emocionais, sociais e contextuais.

O Guia Calgary-Cambridge e o Método SCEBS oferecem ferramentas valiosas para essa adaptação, permitindo uma avaliação biopsicossocial completa e um plano de cuidado mais personalizado e efetivo.



Referências

CUNHA, G. T. **A construção da clínica ampliada na atenção básica**. São Paulo: Hucitec, 2010.

DOHMS, M. C.; COLLARES, C. F.; TIBERIO, I. C. Brazilian version of Calgary-Cambridge Observation Guide 28-item version: Cross-cultural adaptation and psychometric properties. **Clinics**, [s. l.], v. 76, e1706, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.6061/clinics/2021/e1706>. Acesso em: 27 jan. 2026.

KURTZ, S.; SILVERMAN, J.; DRAPER, J. **Teaching and learning communication skills in medicine**. 2. ed. [S. l.]: Radcliffe Publishing, 2005.

MERHY, E. E. Em busca do tempo perdido: a micropolítica do trabalho vivo em saúde. *In*: MERHY, E. E.; ONOCKO, R. (org.). **Agir em saúde: um desafio para o público**. São Paulo: Hucitec, 1997. p. 71-112.

PORTOCARRERO-GROSS, R. Modelo de consulta e habilidades de comunicação. *In*: DUNCAN, B. B. *et al.* (org.). **Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2022.

SANTOS, M. R. P. *et al.* Transcultural adaptation into Portuguese of an instrument for pain evaluation based on the biopsychosocial model. **Fisioterapia e Movimento**, Curitiba, v. 30, supl. 1, p. 183-195, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-5918.030.S01.A018>. Acesso em: 27 jan. 2026.

Ficha técnica

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria de Atenção Primária à Saúde - SAPS
Departamento de Promoção da Saúde - DEPROS.
Núcleo Técnico de Gestão da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS - NTG PNPIC.

Angela Fernandes Leal da Silva – Departamento de Promoção da Saúde - DEPROS.

Paulo Roberto Sousa Rocha – Referência Técnica para a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS – NTG PNPIC/DEPPROS/SAPS/MS.

Daniel Miele Amado – Referência Técnica para a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS – NTG PNPIC/DEPROS/SAPS/MS.

Nathalia Oliveira da Silva – Assessora Técnica no Núcleo Técnico de Gestão da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS – NTG PNPIC/DEPROS/SAPS/MS.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Reitoria

Ursula Rosa da Silva

Vice-Reitoria

Eraldo dos Santos Pinheiro

Coordenação Geral

Julieta Carriconde Fripp - Coordenadora da Cuidativa (Centro Regional de Referência em Cuidados Paliativos FAMED/UFPEL), Diretora da Faculdade de Medicina da UFPEL.

Coordenadora Adjunta

Simone da Fonseca Sanghi - Assistente Social da Cuidativa (Centro Regional de Referência em Cuidados Paliativos FAMED/UFPEL), Colaboradora dos processos de Gestão na Cuidativa.

Ficha técnica

CRÉDITOS DO CURSO

Coordenação Geral

Paulo Roberto Sousa Rocha
Julieta Carriconde Fripp
Simone da Fonseca Sanghi

Apoio Administrativo / Secretaria

Luciano Avila dos Santos

Coordenação de Conteúdo

Amirah Adnan Salman
Bárbara Cury Soubhia
Manuela Samir Maciel Salman

Consultoria e Revisão de Conteúdos

Amirah Adnan Salman
Andrea Cristina Lovato Ribeiro
Bárbara Cury Soubhia
Julieta Carriconde Fripp
Manuela Samir Maciel Salman
Nathalia Oliveira da Silva
Paulo Roberto Sousa Rocha
Simone da Fonseca Sanghi

Coordenação Pedagógica

Amirah Adnan Salman
Andrea Cristina Lovato Ribeiro
Bárbara Cury Soubhia
Manuela Samir Maciel Salman

Coordenação de Pesquisa e Relatórios

Luiz Augusto Facchini
Elaine Thumé
Elaine Tomasi

Coordenação de Mídias e Comunicação

Samir Salman
João Rocha Rodrigues
Luana Copini Jahn

Coordenação de Tecnologia e Informação

Alessander Osório

Coordenação da Produção

Alexandre Moretto Ribeiro
Andrea Cristina Lovato Ribeiro

Revisão Gramatical/Ortográfica e ABNT

Giulia M. Delazzeri

Produção Audiovisual

Eduardo Dias Abreu

Assistente de Produção Audiovisual

Luciana Melo

Animação

Márlon Lima

Ilustração

Mario Cau
Barlo Moreira (cores)

Diagramação e Design Gráfico

Danielle Rossi

Design Web e Programação

Vando Pinto

Conteúdo

Anamaria Siriani de Oliveira
Antonio Seixlack
Arthur Fernandes da Silva
Bernardo Diniz Coutinho
Débora Silva Teixeira
Fabianna Resende de Jesus Moraleida
Fernanda de Figueiredo Torres
Fernanda Martins Pereira Hildebrandt
Fernanda Pereira de Paula Freitas
Francinete Araujo
Josimari Melo de Santana
Juliana Marques Coelho Bastos
Marco Túlio Cária Guimarães Pereira
Marcos Lisboa Neves
Marcos Paulo Veloso Correia
Mariana Cabral Schweitzer
Milene Zanoni da Silva
Rodrigo Macedo Pacheco
Rui Ferreira Afonso
Sandra Fortes

CRÉDITOS DESTE RECURSO DIDÁTICO

Conteúdo

Rodrigo Macedo Pacheco